

SUJET DE CHIRURGIE DIGESTIF N 1

Cas clinique N°1:

Vous recevez à 23h 41mm, au cours de votre garde aux urgences médico-chirurgicales d'Abengourou où vous exercez, Mme YABACHI, 34 ans. Elle est agitée, so plaint de vives douleurs au ventre, présente des vomissements striés de sang à la suite d'une chute sur les fesses dans sa douche.

L'examen physique révèle à l'inspection des battements des ailes du nez, une absence d'excoriations cutanées et à la palpation un en de l'ombilic et une défense généralisée de l'abdomen.

1. De quelle affection souffre Mme YABACHI ? Choisir la bonne réponse

- a- Occlusion abdominale
- b- Péritonite
- c- Contusions abdominales.

2- Relevez parmi les définitions suivantes celle qui correspond à l'affection dont souffre Mme YABACHI?

Choisir la bonne réponse.

A. Il s'agit de traumatismes fermés de l'abdomen sans solution de continuité au niveau de la paroi abdominale

B. Il s'agit d'un arrêt complet et persistant du transit des matières et des gaz dans un segment intestinal donné.

C. Il s'agit d'une inflammation de la cavité péritonéale habituellement causée par une infection bactérienne.

3- Relevez parmi les mécanismes suivants celui qui est responsable de cette affection

- a- Choc indirect par décélération
- b- Choc direct par perforation
- c- Choc direct par percussion

4- Dans quel tableau se trouve Dame YABACHI selon les signes cliniques qu'elle présente ? Choisir la bonne réponse.

a- Tableau d'abdomen contus apparemment normal

b- Tableau d'hémopéritoine

c- Tableau de péritonite par perforation d'organe creux

5- Relevez les deux (2) signes d'irritation péritoneale présentés par Dame YABACHI parmi les suivants.

- a- Pâleur des téguments
- b- Agitations
- c- Cri de l'ombilic
- d- Battement des ailes du nez
- e- Défense généralisée
- f- Vomissements striés de sang

6- Relevez une complication de l'affection dont souffre Dame YABACHY parmi les suivantes:

- a- Plastron appendiculaire
- b- Occlusion intestinale
- c- Péritonite

7- Indiquez l'examen radiologique de première intention médecin demande parmi les

suivants:

a- ASP

b- Echographie

c- Scanner

8- Au cours du traitement médical, relevez parmi les actes de soin suivants, les deux (2) faisant partie de la réanimation de Mme YABACHI

a- Faire un bandage abdominal compressif

b- Retirer le lit de Mme YABACHI

c- Prendre une voie veineuse sûre de préférence au cathéter

d- Poser une sonde urinaire.

e- Préparer une perfusion intraveineuse

9- Relevez deux (2) soins parmi les soins post-opératoires immédiats suivants à appliquer à Mme YABACHI

a- Placer une sonde urinaire

b- Surveillance du pouls, de la tension artérielle pour détecter l'installation d'un état de choc

c- Réhydrater Mme YABACHI

d- Poursuivre la réanimation

e- Prendre une voie veineuse

10- Relevez deux (2) soins parmi ceux à appliquer à Mme YABACHI les jours qui suivent l'intervention chirurgicale ;

a- Alimenter la malade

b- Prélever le sang pour les examens biologiques de contrôle

c- Oxygéner la malade

d- Ablation de la sonde naso-gastrique dès la reprise du transit

e- Ablation des fils si nécessaire un sur deux à partir d'une semaine et total après huit (08) jours.

II-QUESTIONS A CHOIX DOUBLE (QCD):

Répondre par A:Vrai et B:Faux. Aucune réponse = 00 point

11-Les traumatismes de l'abdomen peuvent entraîner des lésions des viscères intra abdominaux

12-Le traitement de la hernie est typiquement chirurgical

13-Les signes d'anémie aiguë se manifestent par une tension artérielle basse avec pincement de la différentielle

14-Le lavement baryté et l'abdomen sans préparation (ASP) sont les examens de confirmation de l'occlusion intestinale

15-En cas de contusion abdominale, l'échographie abdominale ne doit jamais se réaliser au lit du malade

16-La mise en place d'une sonde nasogastrique permet d'éviter le syndrome de Mendelson

17-L'infection appendiculaire se fait rarement par voie sanguine

18-Le syndrome occlusif se caractérise par trois (3) signes physiques et un (1) signe fonctionnel

19-A la période terminale de la péritonite, il apparaît un arrêt des matières et des gaz

- 20-Un role de l'infirmier dans les soins préopératoires est de mettre la malade à jeun la veille de l'intervention
- 21-La rétention d'urine est une affection qui touche seulement les hommes
- 22-Un malade qui présente une occlusion intestinale doit faire l'objet d'une réanimation médicale d'urgence
- 23-Le traitement chirurgical de la péritonite consiste à pratiquer une laparotomie
- 24-La réduction de la hernie étranglée est un geste à proscrire chez le patient vu tardivement
- 25-Le volvulus est un retournement du tube intestinal sur lui-même
- 26-La ponction-lavage est un soin indiqué en cas de météorisme abdominal
- 27-La hernie étranglée est réductible et expansive à la toux
- 28-Le signe clinique majeur définissant l'occlusion intestinale est le météorisme abdominal

Cas clinique N°2:

III- QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE (QCM):

Au cours de vos consultations de routine, vous recevez M. GOLI Age de 55ans qui éprouve une sensation de pesanteur à la marche. A l'examen il présente une tuméfaction transparente à la transillumination, non expansive à la toux du scrotum et des signes de l'inflammation.

29-A quelle pathologie pensez-vous?

- A- Une hernie inguino-scrotale
- B- Une orchite
- C- Une hydrocele

30-Cette pathologie se définit comme;

- A- Un épanchement liquidien séreux entre les deux feuillets de la vaginale sts de la vaginale
- B- Une exteriorisation spontanée temporaire OU permanente d'un viscère qui refoule tous les éléments de la paroi abdominale à travers le canal inguino-scrotal pour se localiser au niveau de scrotum
- C- Une inflammation des testicules

31-Parmi les quatre signes cardinaux de l'inflammation, lequel est un signe fonctionnel?

- A-Tuméfaction
- B- Douleur
- C-Chaleur
- D- Rougeur

32-Parmi les signes énumérés ci-dessous, un seul est le signe capital d'hypothèse diagnostique de cette affection lequel?

- A. L'impossibilité pour le praticien de pincer la vaginale
- B. La tuméfaction transparente à la transillumination
- C. Une peau du scrotum dépliée

Cas clinique N°3:

IV-QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE (QCM):

Vous êtes infirmier au centre de santé rural d GROHOUNFLA arrive à 3 h 00 du d'uriner M. ZAOULI, Planteur, 60 ans vous matin pour impossibilité brutale et totale d'uriner.

33-A quelle pathologie-pensez-vous ?

- A- Rétention urinaire aiguë
- B- Adénome de la prostate
- C- Rétention urinaire chronique

34-Un signe physique parmi ceux énumérés ci-dessous vous conforte dans votre diagnostic lequel?

- A- Impossibilité d'uriner
- B- Besoin impérieux d'uriner
- C- Un globe vésical

35-Un signe fonctionnel parmi ceux indiqués ci-dessous vous rassure pour le diagnostic posé, lequel?

- A- Impossibilité d'uriner
- B- Douleur sous-pubienne plus ou moins intense à la palpation
- C- Globe vésical

36-Indiquez un examen biologique à faire pour confirmer le diagnostic

- A- ASP
- B- UIV avec cliché permictionnel
- C- Bilan sanguin préopératoire usuel

37-Un geste d'urgence peut immédiatement soulager M. ZAOULI, lequel ?

- A. Intervention chirurgicale
- B. Administration d'un antalgique
- C. Sondage urétral d'urgence

38-La pose de la sonde urinaire se fait dans les cas suivants, sauf deux (02); lesquels ?

- A- Rétention d'urines
- B- Douleur sus-pubienne
- C- Infection urinaire
- D- Hypertrophie bénigne de la prostate
- E- Incontinence urinaire

39-Dans la surveillance du patient avant la pose de la sonde urinaire, il faut procéder

- A- A une hygiène des mains du praticien ou de son aide
- B- A Une réfection de lit occupé après toilette générale
- C- A une hygiène du méat, de la région génitale et rectale
- D- A un bain et douche quotidien du praticien au besoin
- E- A une préparation psychologique suivie de prévention d'escarres

40-L'un des objectifs visé dans la démarche de soins infirmiers, en cas de rétention urinaire est

- A-Le retour du mode d'élimination normal des urines
- B-La pose de la sonde urinaire
- C-La ponction sous-pubienne